Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Normalità e patologia nell'età evolutiva

Mattia Antonini
Psicologo e psicoterapeuta
Docente professionista

Tempi della Vita, docenti: Cinzia Campello, Elisa Milani, Paola Blumer, Mattia Antonini
Anno accademico 2025- 2026

Introduzione

- La **psicopatologia** del bambino e dell'adolescente come **situazione paradigmatica** dove osservare i tempi della vita.

- Dai tempi della vita alla **prospettiva evolutiva**, che implica l'uso del costrutto «età evolutiva» come strumento di lavoro.

- Si tratta di una prospettiva che mette al centro **le sfide della crescita** (ad ogni età), che considera **la temporalità** che lavora la soggettività e le relazioni.

- Considerare le particolari **sfide evolutive** di ogni tempo della vita permette
  - **tridimensionalità osservativa**
  - **interventi più ampi e pertinenti**

Genetica e ambiente

- Nello sviluppo umano vi è una traiettoria geneticamente determinata e inarrestabile…ma anche tante **variabili che modulano queste traiettorie**.

- Gli interventi di cura permettono di **accompagnare e modificare** queste traiettorie?

  – *Esempio: Dist. attaccamento > Dist. oppositivo provocatorio > Antisocialità*

Programma

- I quattro assi della valutazione nell'età evolutiva

1. **Sindromico – sintomatica**
   - Dai sintomi ai segni
   - Sintomi come espressione della fatica di crescere
   - Sintomi come segno di malattia
   - Alcune difficoltà della valutazione in età infantile e adolescenziale
2. **Strutturale**
   - Cenno al modello psicodinamico
3. **Evolutivo**
   - Regressioni e fissazioni
   - Linee (compiti) evolutivi (nel bambino e nell'adolescente)
4. **Contestuale**
   - I diversi sistemi del mondo che circonda il bambino

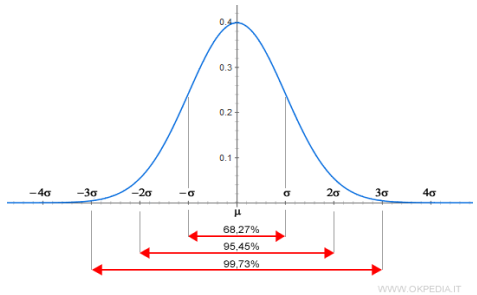
Il concetto di normalità



Le diverse definizioni possibili di normalità possono essere ricondotte a quattro punti di vista (*Marcelli, 1999*), ognuna di queste definizione è problematica:

- **Media statistica**
  - *Normale è un bambino i cui parametri testati rientrano in +/- 1 σ*
- **Ideale a cui avvicinarsi**
  - *Normale è una bambino ideale, le cui performances corrisponderebbero alle attese consce ed inconsce di genitori, scuola, società*
- **Processo dinamico, capacità di tornare ad un certo equilibrio**
  - *Normale è un bambino che si adatta ed è resiliente di fronte agli urti e ai cambiamenti della vita*
- **Salute**
  - *Normale è un bambino non malato*

La norma statistica



- La norma statistica ha un **carattere descrittivo** che evidenzia, in termini esclusivamente quantitativi, la ricorrenza di un particolare evento, senza alcuna considerazione di ordine qualitativo.

- Sono ritenuti «normali» gli eventi che si situano nella frequenza media e «anormali» quelli che non la raggiungono».

- **BMI 18,5–24,9**

- **QI** ~68% delle persone si collocano **tra 85–115**
  (estremi (QI <70 o >130) sono rari)

- **Tuttavia la norma statistica può diventare prescrittiva**, essere caricata di significati sociali e investita da una potente carica affettiva.

Psicometria : esempi

- **ADOS-2 (Autismo):** osservazione diretta di interazione sociale e comunicativa
- **NEPSY-II:** valutazione funzioni esecutive e neuropsicologiche
- **WISC-V:** profilo cognitivo completo
- **Conners 3 (ADHD):** questionari a genitori/insegnanti
- **CBCL:** mappa aree internalizzanti/esternalizzanti
- Questi strumenti possomo aiutare a **superare bias clinici** (p. ex. inibizione, ansia vs limite cognitivo)**, chiarire fenomeni complessi e…garantire coperture assicurative agli utenti.**
- Tuttavia, le scale possono essere usate in modo improprio se interpretate come **confini rigidi tra "normale" e "patologico"**, cristallizzando la persona in un punteggio.

James: primo contatto



- *La madre chiama il Servizio medico psicologico su consiglio del suo psichiatra. Suo figlio James non ascolta, a volte picchia gli altri bambini all'asilo. Allo stesso modo si comporta a casa dove fa di testa sua, urla e scappa anche per strada, prendendo a pugni chi gli sta vicino e graffiando. È difficile uscire con lui ed andare nei negozi. Fa fatica ad addormentarsi e nel cuore della notte si risveglia piangendo, dice che «vede un signore che fa paura». Difficile anche nell'alimentazione, mangia solo pasta in bianco.*

James: anamnesi



- **Gravidanza** non cercata (md 17 enne, pd 16 enne)
- **Parto** cesareo in urgenza, small for date (1880g, 43 cm)
- **Adattamento perinatale** 20 giorni incubatrice, bebè descritto come calmo, con ritmi sonno veglia regolari
- **Allattato** fino ai 6 mesi, svezzato senza difficoltà
- **Alimentazione** descritta come ridotta nella varietà e nella quantità
- **Deambulazione** autonoma raggiunta in epoca a 18 mesi circa
- **Controllo sfinterico** anale e vescicale diurno e notturno riferito conquistato senza difficoltà
- **Sviluppo del linguaggio** apparentemente nella norma e in epoca
- **Prima separazione** (inserimento al pre-asilo) senza particolari difficoltà

La valutazione psicologica del bambino

1. Richiesta di consultazione

2. Anamnesi
3. Incontri
   - *Colloqui con genitori*
   - *Colloqui con bambino/ragazzo*
   - *Osservazione dell'interazione bambino -ge*
   - *Osservazione di gioco / disegno*
   - *(Osservazione a scuola)*
   - *(…)*



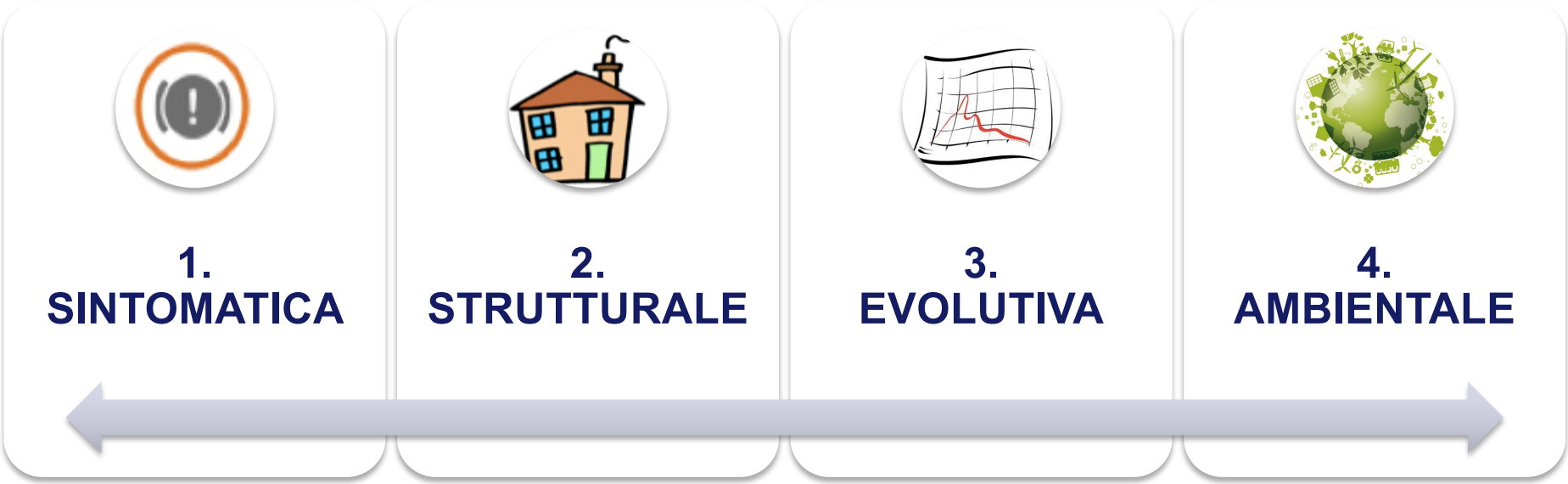
4. Esami strumentali

5. Riflessione

6. Restiuzione (al paziente e/o ai suoi genitori)
   - *Ipotesi diagnostiche e diagnosi differenziali…una descrizione profonda e sensibile di un funzionamento unico*
   - *Ferita narcisistica ma anche opportunità di integrazione*
   - *Prognosi e proposta terapeutica*

I quattro assi della valutazione del bambino e dell'adolescente

- La sintomatologia degli individui immaturi è troppo instabile per servire da base di valutazione. Necessità di una **quadrupla valutazione**:





1. VALUTAZIONE SINTOMATICA

- Sintomo, dal greco syn (insieme) – pipto (cadere): indica il cadere, **l'accadere insieme** di vari avvenimenti.

- In psicoanalisi, storicamente è definito come un **compromesso**
  - *tra la **pulsione e la difesa** (tra forze rimuoventi e ritorno del rimosso).*
  - *Tra **richieste dell'ambiente e salvaguardia di sé**.*

- Sintomo rappresenta un **tentativo di guarigione**

- Il Sintomo rappresenta un **tentativo di narrazione** (a volte raffinato a volte estremamente primitivo)

***Ansia da separazione**: permette restringere il proprio campo di esplorazione, aumentare la vicinanza del caregiver…contenere un desiderio di autonomia sentito come pericoloso….difendersi da sentimenti ambivalenti e ostili verso il caregiver?*

Il sintomo: precisazioni

- In medicina, in senso generale si intende per sintomo **un fenomeno da cui si può inferire l'esistenza di stati morbosi**.

- Sintomi e segni
  - il **sintomo** è da considerarsi una manifestazione soggettiva, riferita dal malato al medico, che deve anzitutto interpretarla identificando la categoria obiettiva cui essa corrisponde. **Obiettivare i sintomi** (attraverso **semeiotica** strumentale e clinica)
  - Il **segno**, invece, è già un fenomeno oggettivo, ossia misurabile, che può essere rilevato dal medico, da persona diversa dal malato o dal malato stesso

- In psichiatria troviamo a volte la distinzione tra:
  - **Sintomi obiettivi**
    - Rilevabili dallo psichiatra
  - **Sintomi soggettivi**
    - Riportati dal paziente stesso

Dal **sintomo** al **segno**: esempi

«Non ho mai voglia di alzarmi dal letto…»



Clinofilia depressiva?
Disturbo del sonno?
Ritiro psicotico?

«Mi pare di flaskare, la realtà diventa come un film…»



Derealizzazione ?
Abuso di sostenze?
Esordio psicotico?



Il sintomo come espressione di una fatica evolutiva (fisiologica)

- Il bambino **sano** può manifestare un **repertorio flessibile di sintomi**. Può manifestare ogni genere di sintomi in alcune circostanze.

- L'assenza di qualsiasi sintomo nel bambino è un evento raro. In alcuni casi, si tratta di un **conformismo adattivo, un falso sé.**

- La **patologia** si manifesta **come limitazione e rigidità** nella capacità del bambino di utilizzare i sintomi. Nel bambino malato i sintomi non stanno (più) facendo il loro lavoro, diventano solo un disturbo per il bambino e per il suo ambiente

Parafrasato da
D. W. Winnicott

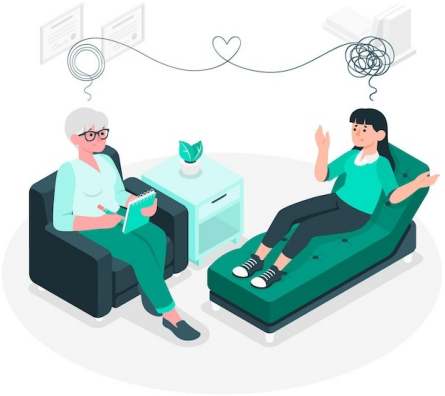
Il sintomo nelle fasi di transizione

- I sintomi in età evolutiva compaiono spesso quando una fase particolare dello sviluppo sottopone a **richieste insolitamente elevate** per la personalità del bambino.

- In questo caso, **il sintomo può aiutare transitoriamente** ad organizzare l'affettività e i pensieri traghettando il bambino oltre il periodo difficile.

- I sintomi possono rappresentare **una richiesta verso l'ambiente di accudimento**:
  - *Per esempio nel bambino piccolo alterazioni delle normali funzioni corporee (fame, sonno, controllo sfinterico) possono rappresentare richieste, rivendicazioni verso l'ambiente di accudimento sentito come insufficiente*

Il sintomo deve sempre preoccupare



- I sintomi nell'età evolutiva sono **espressione fisiologica**
  - della ricerca di un organizzazione interna più adattativa
  - di una richiesta ai caregivers
  - di una ricerca di significato dove livelli di simbolizzazione più maturi sono inaccessibili

>>> *devono essere ascoltati e interpretati (**valore evolutivo**)*

- I sintomi segnalano allo stesso tempo **un problema serio**
  - processi psicopatologici
  - sofferenza psichica
  - possibili gravi disarmonie di sviluppo e disturbi psichici invalidanti

>>> *devono essere curati e superati (**rappresentano un disturbo**)*

Due difficoltà maggiori della psicologia e psichiatria

- **Assenza di *markers* biologici**
  - Sostanze (ormoni, antigeni, …) che segnalano la presenza di un processo morboso.

- **Assenza di sintomi patognomonici**
  - Che consentono di identificare una malattia (associati univocamente ad essa)
  - Infatti molti sintomi sono presenti trasversalmente **ad esempio**:
    - L'**ansia** la si ritrova in quasi tutti i disturbi psichiatrici
    - L'**anedonia** (assenza di interesse in attività normalmente piacevoli) si può trovare nella normale adolescenza, nella depressione e in forme psicotiche
    - Le **dispercezioni** possono essere segni di esordio psicotico all'adolescenza o di abuso di sostanze, o di disturbo del sonno

Studi longitudinali e prevalenza dei disturbi

- Tendiamo a **sovrastimare il valore predittivo di alcuni sintomi** in età infantile e adolescenziale, preoccupandoci molto per ciò che è visibile disturbante (sintomi positivi).

- Non necessariamente i sintomi più rumorosi sono i più preoccupanti. Deliri circoscritti, scariche agite, fenomeni dissociativi…possono avere prognosi molto buone

- Le psicosi più gravi possono avere un esordio lento e insidioso (alterazioni delle funzioni cognitive, diminuzione della spinta vitale…).

- **Necessario sviluppare un ascolto per i silenzi, i vuoti, ciò che manca. (sintomi negativi)**



Original Paper

© Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Early Detection and Intervention in the Initial Prodromal Phase of Schizophrenia

S. Ruhrmann[1] , F. Schultze-Lutter[1] , J. Klosterkötter[1]

- La **maturazione** psicologica e neuronale sono straordinari alleati per la **salute**:

    - *Diminuzione della spinta ad agire*
    - *Miglior controllo emotivo*
    - *Funzione riflessiva più sviluppata*
    - *Più organizzazione interna*
    - *Connettività neuronale più sofisticata e funzionale (pruning)*
    - (…)

Review > Psychol Med. 2009 Feb;39(2):179-95. doi: 10.1017/S0033291708003814.
Epub 2008 Jul 8.

A systematic review and meta-analysis of the psychosis continuum: evidence for a psychosis proneness-persistence-impairment model of psychotic disorder

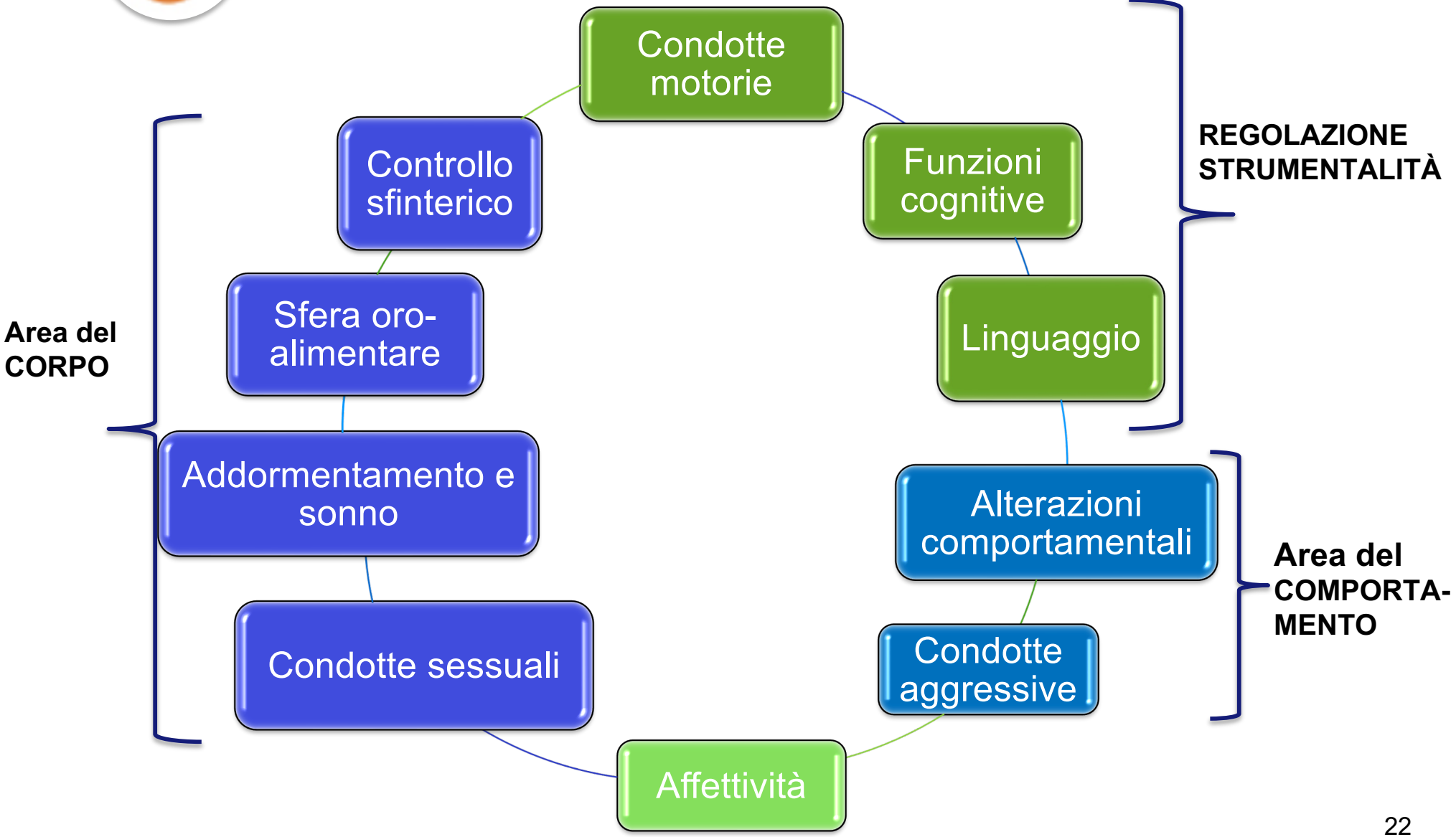
J van Os [1], R J Linscott, I Myin-Germeys, P Delespaul, L Krabbendam

Tasso di prevalenza 5%

75-90% delle esperienze psicotiche subcliniche sono transitorie e scompaiono nel tempo

Ci sono prove, tuttavia, che l'espressione transitoria dello sviluppo della psicosi (propensione alla psicosi) può diventare anormalmente persistente (persistenza) e successivamente clinicamente rilevante (disabilità), a seconda del grado di rischio ambientale a cui la persona è ulteriormente esposta.

1. VALUTAZIONE SINTOMATICA



James: sintomi > segni > diagnosi sindromica



- Sonno disturbato da risvegli e incubi
- Autoregolazione deficitaria
- Comportamenti aggressivi di opposizione
- Quota ansiosa

>>> Disturbo misto del comportamento e della sfera emozionale con esordio nell'infanzia ?

>>> Disturbo di spettro autistico?

>>> Altro?



2. VALUTAZIONE STRUTTURALE

- Valutazione specialistica complessa.
- Ricercare, al di qua là dei sintomi, l'organizzazione profonda del mondo psichico:



Esempio:
Un disturbo alimentare può essere espressione di un disagio di tipo nevrotico, psicotico o limite.

Un'encopresi può manifestarsi in un bambino con un funzionamento di spettro autistico così come rappresentare un sintomo reattivo in un bambino nevrotico in un momento di sofferenza.

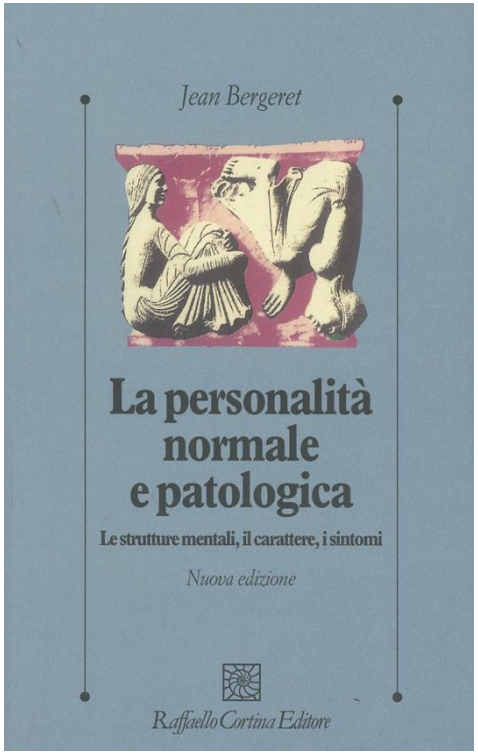
Jean Bergeret

La personalità normale e patologica, 1974

Strutturalista puro, ancorato alla psicoanalisi classica a cui ha apportato importanti contributi.

La griglia diagnostica si fonda su 4 criteri base che il clinico enuclea attraverso il colloquio :

1. *Sintomi*
2. *Difese*
3. *Tipo di angoscia*
4. *Relazione d'oggetto*



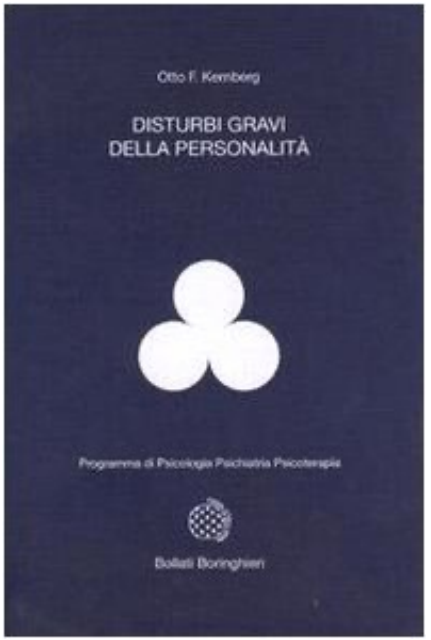
Otto Kernberg

Disturbi gravi della personalità, 1984

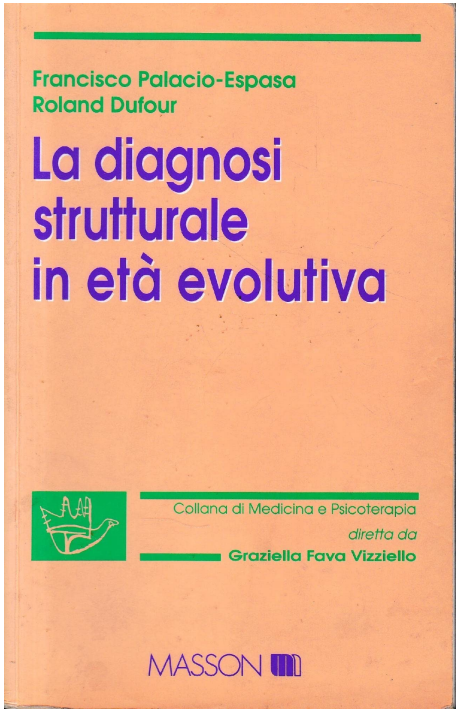
Partendo dallo stesso modello di apparato psi e dalla stessa tripartizione delle patologie (limite, psicotica, nevrotica) individua anche lui dei criteri formali e clinici per porre diagnosi strutturale.

- Tabella dei criteri diagnostici (griglia):

1. *Sintomi*
2. *Integrazione vs dispersione dell'identità*
3. *Difese*
4. *Esame della realtà (forza e coerenza dell'Io)*



Palacio Espasa e Dufour



La diagnosi strutturale in età evolutiva

Proponeuna griglia di valutazione suddivisa in

1. *Impressione generale*
2. *Relazione con l'esaminatore*
3. *Funzioni dell'Io (motricità, intelligenza, linguaggio, esame della realtà, flusso del pensiero*
4. *Affetti*
5. *Meccanismi di difesa*
6. *Espressione pulsioni e fantasmi*
7. *Super Io e Ideale dell'Io*
8. *Concetto di sé (immagine), identificazioni*



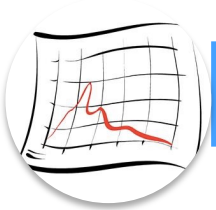
James: griglia diagnosi strutturale (1)

- **Impressione generale**
  - *Bambino normosviluppato, il viso armonioso. Lo sguardo è sfuggente, ha l'espressione triste, quasi assente. Si esprime con poche parole, il suo gioco simbolico invece è più espressivo. Colpisce per l'indifferenza con cui si separa dalla madre.*
- **Relazione con l'esaminatore**
  - *Tendenzialmente evitante, poi più caldo. Richiama l'attenzione ripetendo spesso «guarda». Uscendo concede uno sguardo e un sorriso.*
- **Forze dell'Io**
  - *Motricità non pone problemi, forse un po' goffo*
  - *Potenziale intellettivo poco valutabile*
  - *Linguaggio caratterizzato da ripetitività lessicali e costrutti semplici*
  - *Flusso del pensiero caratterizzato da discontinuità*
  - *Esame di realtà apparentemente conservato*



James: griglia diagnosi strutturale (2)

- **L'affettività e umore**
  - *Esprime piuttosto affetti negativi e il tono dell'umore appare deflesso*
- **Manifestazioni difensive**
  - *Inibizione. Riferiti momenti in cui invece l'aggressività può esplodere.*
- **Pulsioni e fantasmi Immagine di sé e identificazioni**
  - *Contenuti depressivi. I cavalli muoiono, il bambino si ferisce*
  - *Accudimento primario; cibo sonno e igiene.*
- **Immagini di sé e identificazioni**
  - *Sceglie il bebé e si occupa esclusivamente di lui. Immagine di sé articolata intorno ai bisogni primari di accudimento e autonomia nel prendersi cura di sé.*
- **Il super-io**
  - *Difficile valutazione. In ogni caso J. Rispetta il materiale e in confini della consultazione, si serve bene della toilette, mostrando di aver integrato regole di comportamento.*



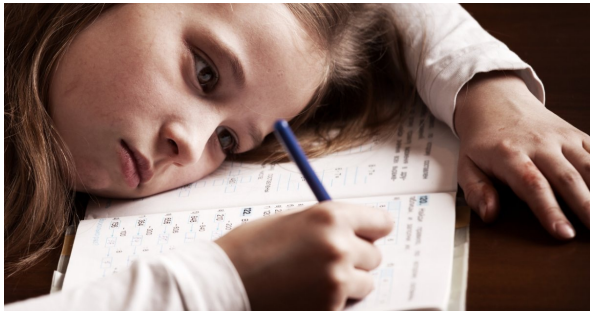
3. VALUTAZIONE EVOLUTIVA

Valutare la struttura nel quadro dei processi di crescita.

La condotta sintomatica è in relazione con il movimento maturativo oppure è ostacolo all'evoluzione maturativa?

Si tratta di considerare quello che succede in relazione a una profonda conoscenza delle diverse linee di sviluppo che sottendono alla crescita dell'individuo.







Processo evolutivo o segno di un disturbo?



- Un certo livello di **dismorfofobia** può essere considerato «normale» all'adolescenza, dove il corpo si trasforma al punto da essere percepito come «strano», «estraneo».

- **Condotte a rischio** nell'adolescenza corrispondono spesso ad una particolare appetenza per l'eccitazione e la ricompensa del cervello adolescente (con un chiaro significato evolutivo e evoluzionistico)

- Le **fobie** specifiche compaiono spesso nel corso dei processi maturativi normali. Intorno ai due anni, si sviluppano potenti capacità immaginative, con esse emergono paure spesso irrazionali.

- Alcune **ossessioni circoscritte** (collezionismo, ordine,…) possono nascere e tramontare nel corso della fase di latenza ordinaria, ed essere di sostegno al bambino

Regressioni e fissazioni

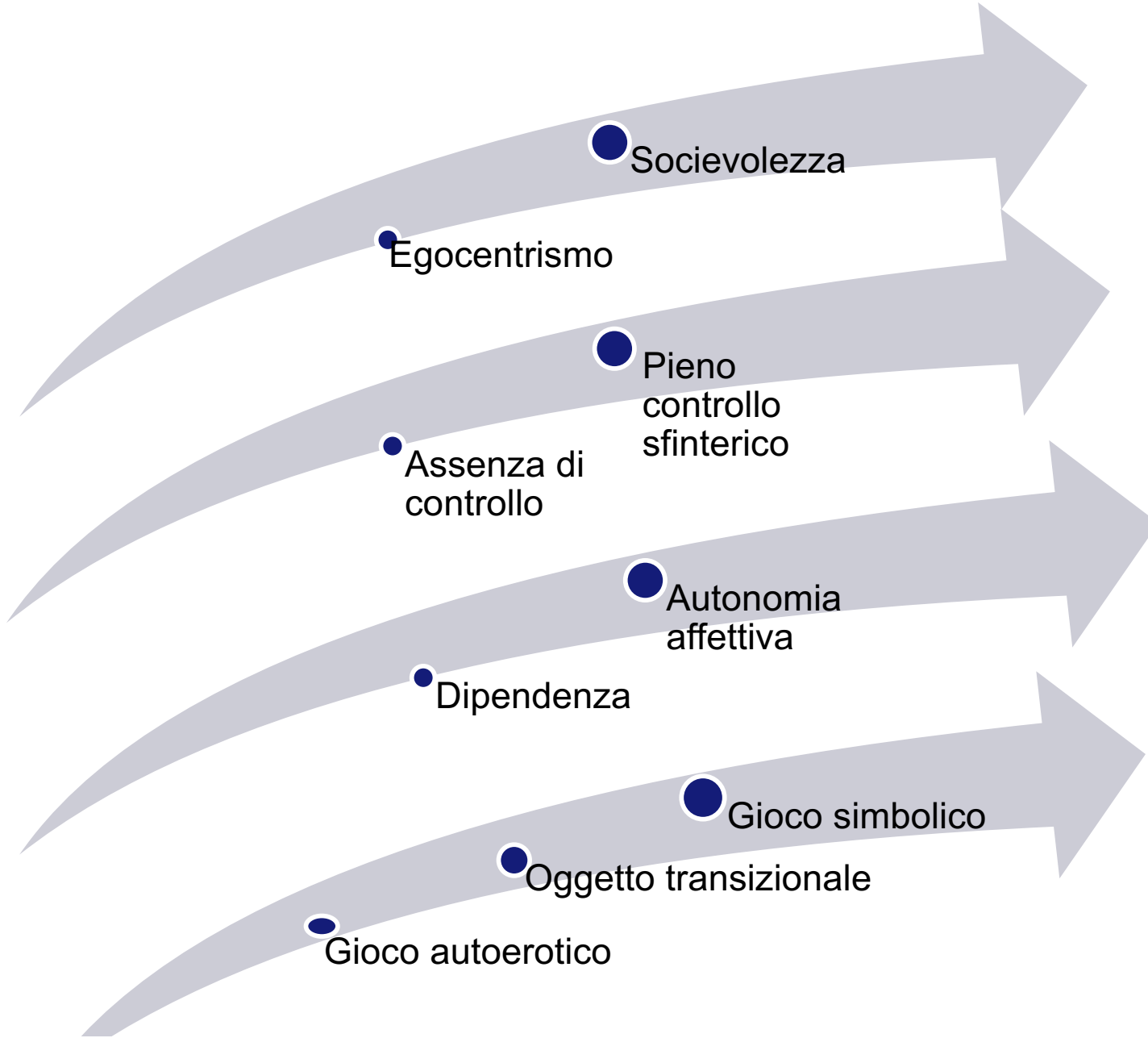
- Mentre dal punto di vista fisico, normalmente, lo sviluppo progressivo è l'unica forza innata in gioco, sul piano psichico dobbiamo fare i conti con una seconda ulteriore serie di **influenze che agiscono in direzione opposta, regressiva.**



- Le tendenze regressive si manifestano in corrispondenza di tutti i risultati importanti raggiunti dal bambino. La regressione si organizza intorno a **punti di fissazione** (dove ci si ferma al sicuro).

- **Ritorni occasionali a comportamenti più infantili** possono essere considerati normali.

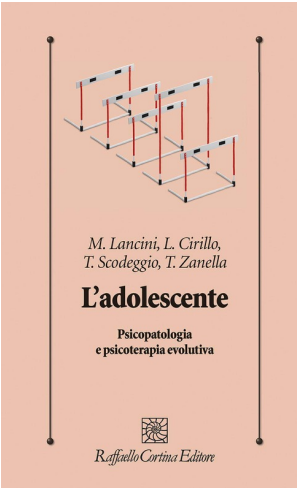
Linee evolutive del bambino





Compiti evolutivi dell'adolescente

- Separazione - individuazione
- Mentalizzazione del sè corporeo
- Formazione di valori
- Nascita sociale





4. VALUTAZIONE AMBIENTALE

Sul piano psicologico il figlio, nasce, cresce e si sviluppa all'interno di una famiglia e da essa è influenzato.

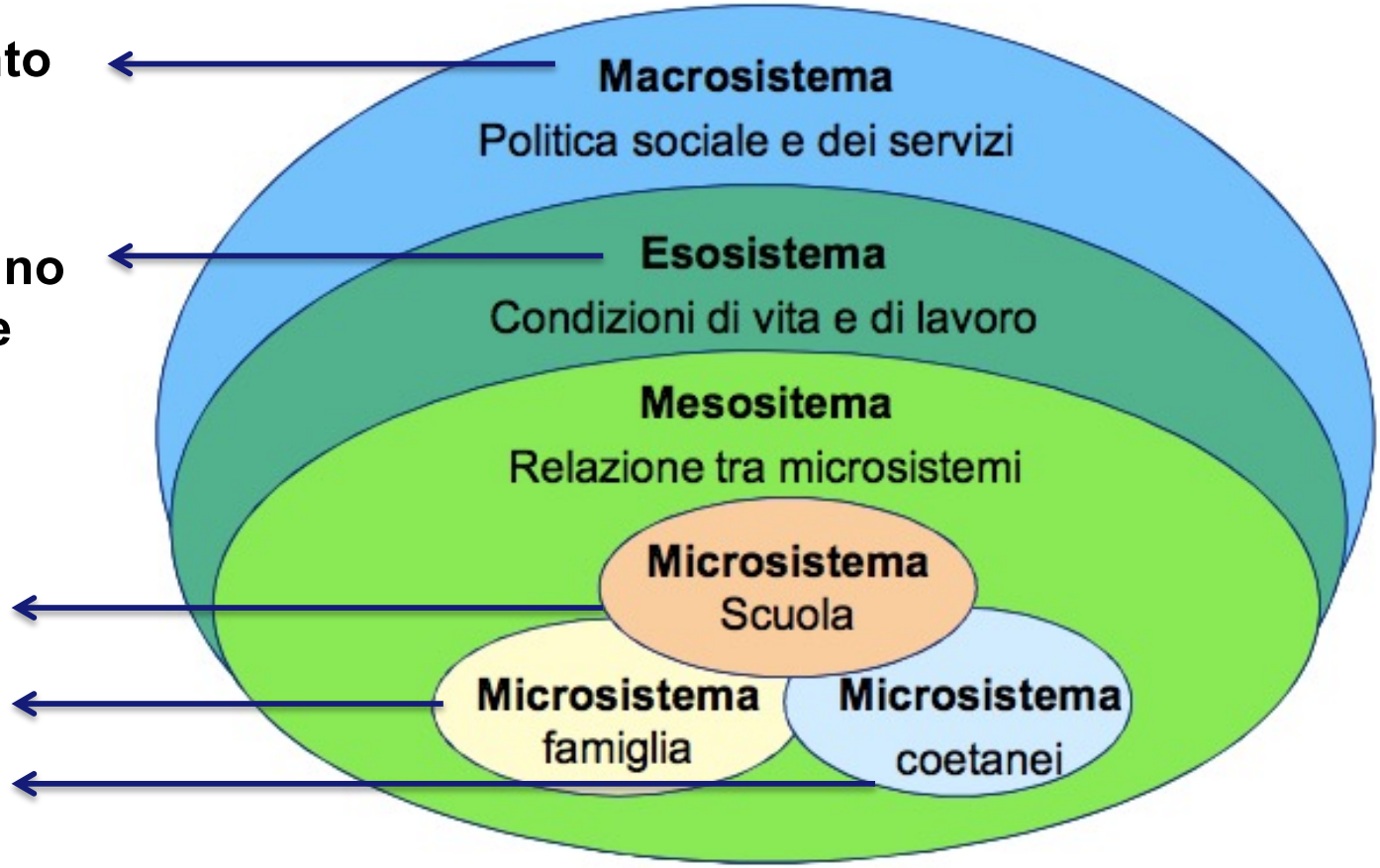
I criteri di valutazione del bambino devono valutare il **contesto**.

In questo caso il sintomo è il **risultato del sistema di interdipendenza dell'individuo con l'ambiente**.

Cultura di riferimento

Contesti in cui il bambino non è coinvolto ma che influenzano il suo funzionamento

Esperienza diretta quotidiana



Es. contesto relazionale nel microsistema famiglia

- ✓ *Funzionamento famigliare, caratteristiche individuali dei genitori, Caratteristiche della relazione adulto bambino, fantasie del genitore sul disturbo del bambino*

James: valutazione ambientale





- Contesto sociale sfavorito (caseggiati mal tenuti, in una zona industriale, in un contesto di emarginazione)
- Famiglia priva di una struttura chiara, dove tuttavia mamma e figlia riescono a sostenersi in una relazione di mutuo aiuto (un po' caotica). Assenza del padre.
- Scuola pubblica solida e accogliente
- Disturbo psichico nel gruppo di accudimento primario
  - La madre soffre di ansia nel contesto di un lieve disturbo di personalità
  - La madre ha un quadro borderline (benché entrambe siano tutto sommato compensate e disponibili in questo momento)

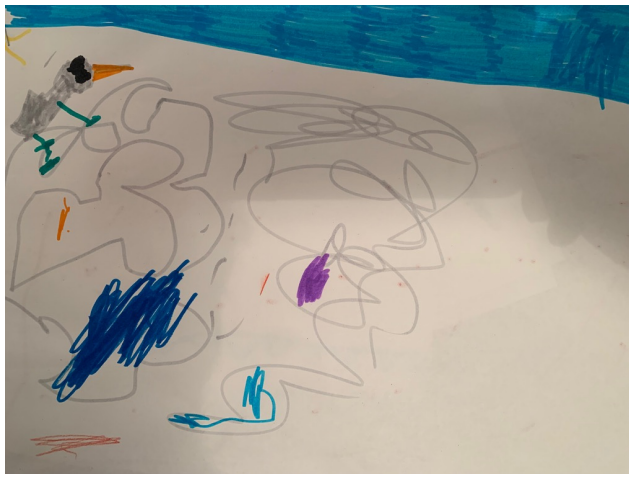
James: ipotesi diagnostiche e indicazioni

- Bambino con buone risorse sufficientemente strutturato ma ansioso e triste. Scarica la tensione nel comportamento ma sa anche esprimere il conflitto simbolicamente.

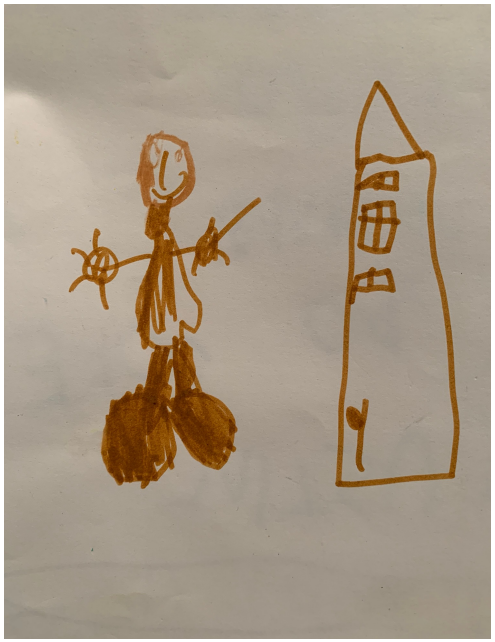
  - **Disturbo misto delle emozioni e della condotta** ICD-10 F92.9
  - **Disturbo psichico del genitore** ICD-10 Z63.8
  - **Condizioni di fragilità psicosociale** ICD-10 Z59.1

- Intervento psicoeducativo a domicilio (SAE o altro)
- Lavoro di rete con SPS
- Seguito psicoterapico che includa in una certa misura anche la madre, orientato alla relazione md-bambino, ma non solo.

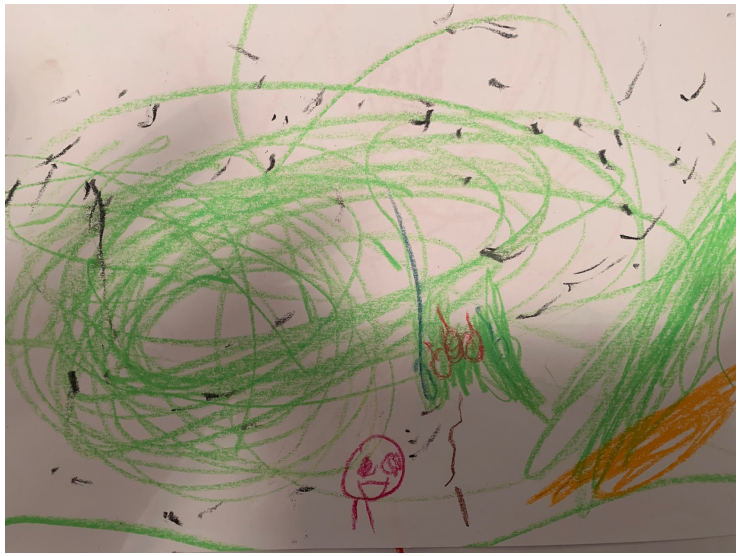
James: catamnesi



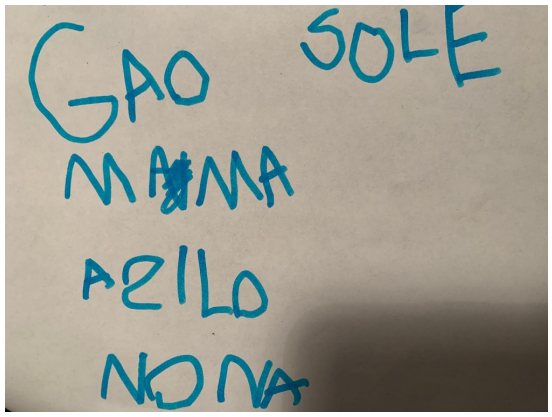
5.5 anni



4.5 anni



6.5 anni



Bibliografia

Testi di riferimento:

Marsicano S. (a cura di, 2007). *Elementi di psicopedagogia*. Milano: Franco Angeli.

Marcelli, D. (1996). *Psicopatologia del bambino.* Milano: Masson. (Cap. Normalità e patologia).

Bracconnier, A. e Marcelli, D. (1996). *Adolescenza e psicopatologia.* Milano: Masson. (cap. Crisi e rottura in adolescenza)

Philipps A. *Winnicot* Harvard University Press, 1989

Freud, A. (1969, 2003). *Normalità e patologia del bambino. Valutazione dello sviluppo.* Milano: Feltrinelli.

Lancini M., Cirillo L. *L'adolescente*, Raffaello Cortina, Milano 2020